

Información Paciente

Nombre : Manuel Alberto Solano Cornejo

Rut : 10.388.587-6

N° Archivo : A168136

N° Epicrisis

298907

Edad : 77a 9m 1d

Fecha Nacto: 23/06/1944

Sexo : Masculino

Dirección : Calle Guillermo Martinez 2534 Santa Rita

Comuna : Pirque

Teléfono : 9 -91344810

Información Hospitalización

Unidad de Ingreso : Upc - Uci Adulto

Fecha Ingreso : 25/02/2022 21:48

Días Estadía: 27

Unidad de Egreso : Utim

Fecha Egreso : 24/03/2022 10:00

Motivo o Diagnóstico de Ingreso

COVID-19

Comorbilidades

Hipertensión Arterial;

Procedimientos

Intervenciones Quirúrgicas

Epidemiología

Resumen Clínico

EPICRISIS MEDICINA INTERNA

24/03/22

Nombre : Manuel Solano Cornejo

RUT : 10388587-6

Edad : 77 años

FI CASR : 25/02/22

FI UCI : 28/02/22

FI UTIM : 10/03/22

FI SALA : 13/03/22

ANTECEDENTES

- Mórbidos: HTA, DLP.

- Quirúrgicos: (-)

- Fármacos: Losartán 50 mg c/12 horas; Atorvastatina 20 mg/día; Hidroclorotiazida 25 mg/día.

- Alergias: (-)

- Hábitos: TBQ (-) OH (-) Drogas: (-)

- Hospitalizaciones: (-)

- Inmunizaciones: (-)

HISTORIA DE INGRESO

Paciente con antecedentes mencionados, debuta el 18/02 con cuadro caracterizado por tos seca ocasional, fiebre cuantificada en 38°C, fatiga y disnea de esfuerzo. Se realiza test de antígeno SARS-CoV-2 el 21/02, resultando (+). Se indicó manejo en domicilio por tratarse de cuadro leve e inició tratamiento con PCT horario, prednisona 20 mg/día y B. Ipratropio 2 puff cada 6 horas. Durante el seguimiento telefónico del 25/02 paciente refiere empeoramiento de disnea y persistencia de fiebre, por lo que se decidió traslado a CASR para evaluación médica. Ingresó en malas condiciones generales, levemente hipertenso (138/67 mmHg), saturando 75% ambiental, se apoyó con MAF 15L logrando recuperar saturación en rango de normalidad (SpO2 97%), sin embargo, persistiendo con mala mecánica ventilatoria. PaFi de ingreso 128. TC de tórax muestra opacidades parenquimatosas pulmonares bilaterales de predominio subpleural y densidad en "vidrio esmerilado" que comprometen el LSD, LM, ambos LI y en menor medida segmento lingular y lóbulo superior izquierdo. Se intentó CNAF + prono vigil, frustrados, por lo que se decidió IOT + VMI + BNM el 27/02. Se traslada a UCI.

Fecha Epicrisis : 24/03/2022 10:05

DIAGNÓSTICOS DE INGRESO

1. Neumonía grave secundaria a COVID-19
 - ¿ VMI 27/02
 - ¿ BNM 27/02-01/03
2. FA paroxística con RVR
3. Bradicardia sinusal
 - ¿ Farmacológica vs ENS

EVOLUCIÓN

-HDN/CV: Se describe al ingreso estable, HDN inicialmente con requerimiento de NAD en relación a sedoanalgesia. Durante el periodo de VMI evoluciona con bradicardia sinusal, interpretada como secundaria a fármacos. Al ingreso a UCI se habría evidenciado FA con RVR, que se manejó con betabloqueo. De momento sin nuevos episodios de FA. Sin uso de BB. Evoluciona estable, sin signos de deshidratación. Reinicia VDO habituales sin inconvenientes. Dado debut de FA en contexto de paciente crítico, se desestima necesidad de anticoagulación a permanencia. Sin conflicto durante hospitalización.

- Ventilatorio: NAC COVID-19 grave día 24. BNM durante sus primeras 48 horas de VMI en UCI. Completó 10 días de dexametasona por protocolo RECOVERY. Intubado durante 11 días. Extubado el 09/03. Evoluciona de manera favorable con titulación de O2 a la baja, logra suspender O2 suplementario el 18/03. Se mantiene broncodilatación y kinesioterapia respiratoria.

-Infeccioso: Neumonía asociada a ventilación mecánica por H. Influenzae tratada. El día 11/03 presenta peak febril con estudio microbiológico (-), se desestima necesidad de terapia antibiótica. Presenta episodio de retención de orina completa el 19/03, se complementa estudio con OC: inflamatoria, UC (+) PsAe S Amikacina. PSA total: 11.8. Cuadro se interpreta como prostatitis aguda. Actualmente en su tercer día de Amikacina. Se realiza traslape a Ciprofloxacino en plan de completar 4 semanas de terapia ATB.

-Renal/Medio Interno: Al ingreso con AKI KDIGO I, interpretada como prerrenal, que resolvió con volemicización. Progresa con Hipokalemia + Hipernatremia en relación a poliuria post obstructiva. Actualmente en resolución, Na control: 149. Mantener hidratación abundante en domicilio. Control medio interno en 7 días.

- Uro: Presenta episodio de retención aguda de orina el día sábado. Dentro de estudio destaca OC inflamatoria, UC + PSAE, PSA total elevado. Se interpreta como prostatitis aguda. Mantener S. Foley. Ciprofloxacino 500 mg c/12 hrs x 4 semanas, Tamsulosina 0.4 mg/ día. Control con especialidad en 30 días para evaluar retiro de sonda.

- Neurológico: El 12/03 presenta episodio de disminución de fuerza asimétrica entre extremidades derechas e izquierdas y leve desviación de comisura labial a derecha. Se describe lenguaje inteligible. Se realiza TAC de cerebro sin evidencia de lesiones agudas. Evaluado por neurología quien sugiere complementar estudio con RM de encéfalo protocolo stroke con angioRM cerebro y cuello: Sin lesiones. Reevaluado por equipo a quienes concluyen hipotonía orofacial, sin patología neurológica actualmente. Continuar sesiones con fonoaudiología disartria y trast deglución multifactorial. Control SOS por equipo.

-Rehabilitación: Paciente se mantiene en KNT motora en buen control de tronco y cuello. En seguimiento por fonoaudiología, reinicia alimentación complementaria el 22/03 sin inconvenientes. Se logra retiro de SNG el 23/03. Delirium en resolución, se ajustan neurolépticos. Se mantiene en rehabilitación kinésica y fonoaudiológica intensiva vía hospitalización domiciliaria.

LABORATORIO

24/03: Hb: 10.6, Hto: 33.1, Leuco: 8600, RAN: 5400, Plaq: 259.000, Crea: 0.88, BUN: 27.4, P: 3.5, P: 3.5, PCR: 2.4, ELP: 149/3.56/119, PH: 7.44, PCO2: 32, HCO3: 21.5.

23/03: Hb: 11.8, Leuco: 9650, RAN: 6300, Plaq: 32000, Crea: 0.87, BUN: 36.6, ELP: 151/3.6/118, PSA total: 11.8.

13/03: Hb: 10.8, Leuco: 10970, RAN: 8300, RAL: 1600, Plaq: 233.000, Crea: 0.7, BUN: 15.5, PCR: 33, PH: 7.42, PCO2: 27.9, HCO3: 17.7

21/03: OC: inflamatoria, UC: PSAE s Amikacina, Cipro.

11/03: OC: NI, UC (-); Portación carbapenemas, ERV (-)

11/03: HC I y II (-) 48 hrs. Cultivo arrastre catéter (-) 48 hrs.

Angio RM cerebro 22/03: Examen sin evidencia de una lesión isquémica o hemorrágica reciente. Cambios microangiopáticos

Fecha Última Actualización: 24-03-2022 10:05:09

Página 3 de 4

de la sustancia blanca supratentorial. Angio-RM de cerebro sin hallazgos patológicos.
11/03 Sedimento de orina no inflamatorio, bacterias muy escasas.

DIAGNÓSTICOS DE EGRESO

1. Insuficiencia respiratoria Aguda
 - a. Neumonía COVID-19 grave.
 - b. FIS 18/02
 - c. Test de antígeno (+) 21/02
 - d. VMI 27/02-09/03, BNM 27/02 al 01/03
2. NAVM por H. Influenzae tratada
3. AC x FA paroxística con RVR resuelta
4. RAO 19/03
 - Prostatitis Aguda
 - UC (+) PsAE MS
5. Poliuria post-obstruiva
 - Hipernatremia moderada en resolución
 - Hipokalemia resuelta
6. Hipotonía orofacial en rehabilitación
7. AKI KDIGO I resuelta
8. Antecedentes

Diagnóstico de Egreso

Neumonía Adquirida en la Comunidad (NAC) - Nac Covid+19

Condición de Egreso

Otro

Egreso con Catéter Doble J:NO

Buenas condiciones generales, HDN estable, afebril, sin requerimientos de O2 suplementario. Completando fase de rehabilitación kinésica y fonoaudiológica. Requiriendo sonda Foley por retención urinaria en relación a prostatitis.

Plan Post Alta

INDICACIONES

Reposo relativo, activar por KNT. Sentar a sillón.
Régimen licuado + jalea en almuerzo y cena semisentado, 100% asistido. Agua libre a demanda 100% asistido.
Aseo Bucal 2 veces x día
O2 para sat 92-94%.
KNT R y M, seguimiento diario por Fono
Cuidados de Sonda Foley

Ciprofloxacino 500 mg c/12 hrs VO x 28 días
Amlodipino 10 mg/día VO a permanencia
Losartán 50 mg c/12 hrs VO a permanencia
Carvedilol 6.25 mg c/12 hrs VO a permanencia
Tamsulosina 0.4 mg/ día VO a definir por Urología
Bromuro de ipatropio 2 puff c/6 hrs por AC a permanencia
Quetiapina 12.5 mg PM VO a permanencia

CONTROLES

Mantener rehabilitación kinésica y fonoaudiológica vía hospitalización domiciliaria.
Control con Urología en 30 días. Evaluar prostatitis, eventual retiro de S. Foley.
Control con exámenes en CESFAM en 7 días. Vigilar Fx renal, ELP, control de parámetros inflamatorios.

Fecha Epicrisis : 24/03/2022 10:05

Página 3 de 4

Fecha Última Actualización: 24-03-2022 10:05:09

Página 4 de 4

Acudir al servicio de urgencia en caso de compromiso de consciencia, dificultad motora, desviación comisura bucal, fiebre, sintomatología respiratoria, ausencia de diuresis en recolector o en caso que estime necesario.

Llaría/ Neumann

Indicaciones

Tipo de Reposo :

Régimen Alimentario :

Medicamentos :

Controles

31/03/2022 - APS - - Evaluar medio interno, Fx renal, control de PI

18/04/2022 - CDT - Urología - Prostatitis, retención urinaria. Evaluar Retiro Foley

INTERNO

Bec. José Antonio Llaría Fuenteal
Becado/Residente



Ignacio Neumann Burotto
Médico Tratante (Staff)